

Stranieri e sicurezza sociale + Sistema sanitario e LAMal

Sicurezza Sociale e Forme di Solidarietà · Sessione 09 · 22 maggio 2026

Questa lezione è doppia: nella prima parte capisci come funziona (e quanto è complicato) il rapporto tra stranieri e welfare in Svizzera. Nella seconda, entri nel cuore del sistema sanitario svizzero con la LAMal — come si finanzia, perché è problematica, e cosa si sta cercando di fare. Due argomenti che si toccano spesso nella pratica del lavoro sociale.

Parte 1 — Stranieri e sicurezza sociale in Svizzera

Perché l'argomento è fondamentale

La sicurezza sociale svizzera non può essere compresa senza considerare il ruolo della popolazione straniera. Non è un tema marginale: circa **1 persona su 4** che risiede in Svizzera non ha la cittadinanza svizzera.

Dati dell'**Ufficio federale di statistica (2025)**: - Popolazione residente permanente totale: **9,1 milioni** - Stranieri residenti permanenti: **2,4 milioni** - Oltre i **2/3** provengono da paesi UE/AELS - Il **73%** dell'immigrazione 2025 riguarda cittadini UE/AELS, motivazione principale: il lavoro

Attenzione all'idea sbagliata comune: gli stranieri non "approfittano" del welfare — al contrario, lo finanziano versando contributi sociali e pagando le imposte.

La tensione strutturale: inclusione economica vs. condizionalità sociale

Il rapporto stranieri–welfare è attraversato da una tensione costante:

- **Inclusione economica:** gli stranieri lavorano, contribuiscono, pagano contributi e imposte → sono dentro il sistema
- **Inclusione sociale e giuridica condizionata:** l'accesso pieno ai diritti dipende dal permesso, dalla durata del soggiorno, dalla nazionalità, dai contributi versati, dalla situazione economica

In Svizzera, storicamente, la persona straniera è stata vista come: - lavoratore utile (o "forza lavoro") - presenza provvisoria - rischio sociale / costo potenziale - persona da integrare - persona da controllare

"Ricercati ieri, tollerati oggi, cacciati domani" — frase riportata su uno striscione della manifestazione di Zurigo del 1° maggio 1976.

Pensa all'ecosistema di una foresta: alcune specie sono indispensabili (fissano l'azoto, impollinano), ma vengono comunque classificate come "invasive" quando abbondano troppo. È un po' la stessa doppia lettura che si applica agli stranieri nel discorso pubblico svizzero — necessari, ma non del tutto benvenuti.

Evoluzione storica

XIX secolo: welfare locale e cittadinanza

Il welfare nasce all'interno dello Stato nazionale. La protezione sociale era legata al **comune d'origine**, alla cittadinanza e all'appartenenza alla comunità locale.

Gli stranieri non avevano accesso all'assistenza pubblica → dipendevano dalla beneficenza privata o religiosa → potevano essere espulsi o rimandati in caso di povertà.

Questa logica non è scomparsa del tutto: ancora oggi i requisiti per il permesso di soggiorno includono la dimostrazione di autonomia economica (lavoro o risorse sufficienti).

Industrializzazione e "Überfremdung"

L'industrializzazione aumenta la domanda di manodopera straniera (edilizia, industria, ferrovie, albergheria). Ma cresce anche la paura politica e sociale dell'**inforestierimento** — in tedesco **Überfremdung** — ovvero l'idea che la presenza straniera minacci l'identità nazionale, aumenti i conflitti sociali e pesi sul welfare.

Gli stranieri sono economicamente necessari, ma socialmente e politicamente considerati "temporanei".

Nota: negli anni 70 si arrivò al paradosso per cui le prime proteste sindacali in Svizzera venivano descritte come "non svizzere" — erano "colpa degli stranieri" che portavano idee radicali.

Lo statuto di stagionale (1931–2002)

Nel **1931** nasce lo **statuto di lavoratore stagionale**, abolito solo nel **2002** con l'accordo sulla libera circolazione. La logica era: importare forza lavoro senza permettere un insediamento stabile.

Lo stagionale: - poteva lavorare solo temporaneamente - era fortemente dipendente dal datore di lavoro (permesso legato a quel contratto specifico) - non poteva facilmente cambiare impiego - **non aveva diritto al ricongiungimento familiare** ← punto più critico - viveva spesso in condizioni precarie (baracche sui cantieri) - aveva accesso molto limitato all'assistenza sociale

Nel film visto a lezione si vedevano i "bambini nascosti": figli di lavoratori stagionali che, non avendo diritto al ricongiungimento familiare, vivevano illegalmente in casa, reclusi, senza andare a scuola. La polizia faceva controlli, i bambini si nascondevano negli armadi. Ancora oggi molte persone adulte ricordano questi periodi di reclusione.

"Lavoratori sì, ma non cittadini"

Gli stagionali lavoravano legalmente e **pagavano i contributi** (AVS, AI, IPG, assicurazione infortuni). Non erano "fuori" dal sistema economico. Ma cosa succedeva ai loro diritti maturati quando tornavano al paese d'origine?

Dal dopoguerra alla libera circolazione (1950–2002)

Dopo la Seconda guerra mondiale la Svizzera recluta massicciamente lavoratori stranieri: soprattutto italiani, spagnoli, portoghesi, jugoslavi. Versano contributi, ma spesso tornano nel paese d'origine.

Il problema dei diritti maturati porta alle **convenzioni bilaterali di sicurezza sociale**: - **1962**: Convenzione Svizzera-Italia → prima esportazione delle rendite, coordinamento AVS/AI - **2002**: Accordo sulla libera circolazione delle persone → coordinamento completo tra Svizzera e UE in materia di sicurezza sociale

Grazie a queste convenzioni, una persona può lavorare in più paesi senza perdere i diritti maturati — niente "buchi contributivi" nella pensione.

Attenzione: la libera circolazione non elimina tutte le differenze, non rende il welfare universale, e non cancella il legame tra permesso di soggiorno e autonomia economica.

I tre criteri che determinano i diritti sociali degli stranieri oggi

Criterio	Cosa conta	Esempi di prestazioni
Contribuzione	Ha lavorato e versato contributi?	AVS, AI, disoccupazione, 2° pilastro
Residenza	Vive stabilmente in Svizzera con quale statuto?	Assicurazione malattia obbligatoria, aiuto sociale, prestazioni complementari
Statuto	Che tipo di permesso ha?	Permesso L, B, C, F, N, statuto S, sans-papiers

Tipi di permesso e accesso alle prestazioni

Permesso	Chi riguarda	Accesso prestazioni	Criticità principale
C (domicilio)	~10 anni di residenza	Ampio, quasi come cittadino svizzero	Revoca possibile per dipendenza durevole da aiuto sociale (LStrl Art. 63)
B UE/AELS	Lavoratori UE, 5 anni	Assicurazioni legate al lavoro	Aiuto sociale può influire sul diritto di soggiorno (LStrl Art. 62)
B Stato terzo	Fuori UE/AELS	Prestazioni contributive se si lavora	Maggiore vulnerabilità al rinnovo permesso
F	Ammessi provvisoriamente	Accesso limitato ma esistente	Forte precarietà amministrativa e lavorativa
N	Richiedenti asilo	Sostegno specifico settore asilo	Diritti ridotti, forte dipendenza istituzionale
S	Statuto di emergenza	Diritti più vantaggiosi rispetto ad altri richiedenti asilo	Statuto temporaneo
Sans-papiers	Senza statuto regolare	Diritti molto limitati	Paura segnalazione, invisibilità sociale (Cost. fed., Art. 12)

La distinzione fondamentale: assicurazioni vs. assistenza

Assicurazioni sociali (basate su lavoro e contributi): AVS, AI, disoccupazione, previdenza professionale, infortuni. Per le persone che lavorano, l'accesso è garantito allo stesso modo per svizzeri e stranieri.

Prestazioni assistenziali (basate sul bisogno economico): aiuto sociale, prestazioni cantonali (RIPAM, AFI/API), sostegni comunali. Qui entrano in gioco le condizioni migratorie.

Per molti stranieri il problema principale non è l'accesso formale alle assicurazioni sociali contributive, ma le conseguenze amministrative e migratorie del ricorso all'assistenza sociale.

Il problema della "non-domanda"

Questo è uno dei punti più critici — e più rilevanti per il tuo futuro ruolo come operatore sociale.

Molte persone straniere rinunciano a chiedere aiuto sociale anche quando ne avrebbero diritto, per paura delle conseguenze sul permesso di soggiorno.

Il meccanismo: al momento del rinnovo del permesso, viene verificato se la persona ha ricevuto aiuti sociali. In alcuni casi — analizzati caso per caso — il permesso può non essere rinnovato ("dipendenza durevole e considerevole", formula intenzionalmente vaga nella legge).

Caso citato a lezione: una donna nigeriana residente a Zurigo da 30–40 anni, con permesso C, ha smesso di lavorare per accudire la madre gravemente malata. Ha richiesto aiuti sociali. Al rinnovo, le è stato comunicato che aveva ricevuto "troppi" aiuti e che avrebbe dovuto rientrare in Nigeria. Dopo decenni in Svizzera.

Effetti della non-domanda: - Ritardo nella presa a carico (si arriva alla crisi già avanzata) - Indebitamento - Rinuncia alle cure mediche - Precarietà abitativa - Peggioramento della salute - Maggiore vulnerabilità lavorativa - Dipendenza da reti informali o lavoro in nero

Uno studio del 2021 (Borrelli, Kurt, Achermann, Pfirter) mostra come in Svizzera il ricorso all'aiuto sociale possa trasformarsi in uno **strumento di controllo migratorio**: i "diritti sociali condizionati" non sono universali, ma vincolati alla politica migratoria.

La domanda per gli operatori sociali

«Un diritto sociale è davvero accessibile se esercitarlo può mettere a rischio la stabilità del soggiorno?»

È una domanda provocatoria ma fondamentale. I diritti sociali dovrebbero essere universali — hai bisogno, chiedi. Ma se chiedere mette a rischio la possibilità di rimanere nel paese, siamo davanti a **diritti sociali condizionati**.

Bene, ora passiamo alla seconda parte — il sistema sanitario. Se il welfare per gli stranieri è complicato, la LAMal è il caso perfetto per capire come un sistema si può costruire con buone intenzioni ma risultati strutturalmente iniqui.

Parte 2 — Il sistema sanitario e la LAMal

Una spesa sempre crescente

Nel 2021 i costi del sistema sanitario svizzero hanno raggiunto **9'924 CHF per ogni residente**. Nel 1996, all'entrata in vigore della LAMal, erano 5'292 CHF. In 24 anni: **+88%**. Nello stesso periodo il PIL pro-capite è aumentato solo del **41%**.

La spesa sanitaria cresce indipendentemente dall'andamento economico — anche negli anni di crisi (2002, 2009, 2015, 2020) ha continuato a salire.

I quattro principali fattori che spingono i costi:

1. **Progresso tecnologico** — farmaci nuovi che sostituiscono i vecchi (più efficaci ma molto più cari), senza ridurre la spesa globale

2. **Invecchiamento della popolazione** — più anziani = più cure = più costi. Il Canton Ticino stima +26% posti letto in case anziani e +62% ore cure a domicilio entro il 2030
 3. **Malattia dei costi di Baumol** — i servizi alla persona non si possono automatizzare facilmente → produttività strutturalmente bassa → costi sempre alti (Baumol, economista anni 60)
 4. **Aspettative crescenti** — problemi che un tempo si gestivano da soli oggi portano da medici, fisioterapisti, psicologi
-

Come si finanzia la sanità in Svizzera (2021)

Fonte	% spesa totale
LAMal (assicurazione obbligatoria di base)	35,8%
Stato (Cantoni, Confederazione, Comuni)	23%
Economie domestiche (franchigia, quota parte, ecc.)	22,3%
Altre assicurazioni sociali (infortuni, AI, militare)	9%
Assicurazione complementare	6,5%
Altre fonti	3,5%

La LAMal ha il ruolo principale ma non è maggioritaria: il sistema è articolato su più fonti di finanziamento.

Cos'è la LAMal e perché è un unicum

La **LAMal** (Legge federale sull'assicurazione malattie) è entrata in vigore nel 1996. Introduce l'assicurazione obbligatoria contro le malattie per tutta la popolazione residente in Svizzera.

Prima del 1996 esistevano già le casse malati, ma non erano obbligatorie a livello federale (solo in alcuni Cantoni: Ticino, Ginevra, Friburgo). Il sistema era frammentato e stava diventando insostenibile per i costi.

La peculiarità che la rende unica tra le assicurazioni sociali svizzere:

I premi LAMal **non sono basati sul reddito**. Tutti i residenti pagano lo stesso premio indipendentemente da quanto guadagnano (con variazioni solo per regione, età, livello di franchigia e modello assicurativo).

Nelle altre assicurazioni sociali (AVS, AI, disoccupazione) i contributi sono proporzionali al salario — ad esempio il 4,35% per l'AVS. Nella LAMal no.

Questo rende il sistema intrinsecamente iniquo: il premio è un peso proporzionalmente molto più pesante per chi guadagna poco rispetto a chi guadagna molto.

Le casse malati sono **enti privati** (circa 50 oggi). Non si è creata una cassa unica pubblica: si è scelto di riconoscere le casse private già esistenti e di obbligarle a offrire un catalogo minimo uniforme di prestazioni.

I correttivi all'iniquità del sistema

Il legislatore era consapevole del problema e ha previsto due meccanismi correttivi principali:

1. Sussidi di riduzione dei premi (IPT) Nel 2020: 2,9 miliardi dalla Confederazione + 2,6 miliardi dai Cantoni → circa il **28% degli assicurati** ha ricevuto sussidi.

Limiti del sistema dei sussidi: alti costi amministrativi, effetti soglia (piccole differenze di reddito = grandi differenze di sussidio), profonde differenze tra Cantoni.

2. Finanziamento pubblico degli ospedali I Cantoni finanziano il 55% dei costi ospedalieri stazionari. Questo finanziamento proviene dalle imposte, che sono **progressive** (più guadagni, più paghi in percentuale crescente). **Quindi chi ha redditi alti contribuisce di più al sistema sanitario indirettamente, attraverso le imposte.**

Solidarietà verticale e orizzontale

Solidarietà verticale = redistribuzione tra fasce di reddito. Chi guadagna di più contribuisce maggiormente al sistema attraverso le imposte progressive. È il principio che ispira anche il sistema di sussidi IPT.

Solidarietà orizzontale = redistribuzione tra gruppi sociodemografici, non tra fasce di reddito. - Nell'assicurazione malattia: i **sani** finanziano i **malati** - Nell'AVS: i **lavoratori attivi** finanziano chi è **in pensione**

Come funzionano le aliquote progressive: su 20'000 CHF si è esenti dall'imposta. Poi si applica l'1% sui primi 1000 franchi che superano i 20'000, poi una percentuale crescente su quello che resta. Il 40% circa dei contribuenti svizzeri non paga imposte (reddito imponibile sotto la soglia). Chi guadagna molto paga aliquote molto più alte.

Il dibattito politico attuale

A fine settembre 2023, l'annuncio di aumenti pesanti dei premi LAMal per il 2024 (+8,7% nazionale, +10,5% in Ticino) ha riaperto il dibattito.

Destra: ridurre la copertura LAMal e/o aumentare la franchigia per responsabilizzare i cittadini.

Sinistra: aumentare i sussidi strutturalmente in modo che i premi netti non superino il 10% del reddito; nel medio periodo, **cassa malati unica pubblica con premi basati sul reddito** (proposta che alle votazioni non è passata, ma ha trovato sostenitori anche in centro-destra in Ticino).

La proposta di aumento della franchigia minima (2026)

Il Consiglio federale ha posto in consultazione una modifica LAMal che aumenterebbe la franchigia minima da **300 a 400 franchi** (proposta **Esther Freidli, UDC**, adottata dal parlamento nel **marzo 2025**).

Logica ufficiale: aumentare la responsabilità individuale degli assicurati per contenere i costi. L'ultimo aumento della franchigia risaliva al 2004 (da 230 a 300 franchi).

Critiche: penalizza i malati cronici e chi ha risorse limitate — che già oggi rinunciano alle cure per motivi economici. E il vero problema (invecchiamento + tecnologia) non si risolve con la franchigia.

In classe è emerso che aumentare la franchigia e spingere verso l'assistenza domiciliare rischia di far ricadere il carico di cura sui familiari (soprattutto donne), che si trovano a fare lavoro di cura non retribuito. Chi non ha una rete familiare è particolarmente vulnerabile.

Concetti chiave

Termine	Significato
Überfremdung / inforestierimento	Paura politica che la presenza straniera minacci identità nazionale e welfare
Statuto di stagionale	Permesso lavoro temporaneo (1931–2002): lavorare sì, stabilizzarsi no
Criterio della contribuzione	Diritti basati sul lavoro e sui contributi versati (AVS, AI, disoccupazione)
Criterio della residenza	Diritti basati sulla stabilità del soggiorno (es. LAMal obbligatoria)
Criterio dello statuto	Diritti dipendenti dal tipo di permesso (L, B, C, F, N, S, sans-papiers)
Diritti sociali condizionati	Diritti formalmente esistenti ma il cui esercizio può avere conseguenze migratorie
Problema della non-domanda	Rinuncia all'assistenza sociale per paura di perdere il permesso

Termine	Significato
LAMal	Legge federale assicurazione malattie (1996): obbligatoria, premi non basati sul reddito
Malattia dei costi di Baumol	Servizi alla persona non automatizzabili → produttività bassa → costi strutturalmente alti
Sussidi IPT	Riduzione premi LAMal per redditi bassi: correttivo parziale all'iniquità
Solidarietà verticale	Chi guadagna di più contribuisce di più (tramite imposte progressive)
Solidarietà orizzontale	Sani finanziano malati; lavoratori attivi finanziano pensionati
Franchigia	Soglia di spesa personale prima che la LAMal copra i costi (attuale 300 CHF, proposta 400 CHF)

Domande di orientamento allo studio

Qual è la tensione strutturale che attraversa il rapporto tra stranieri e sicurezza sociale in Svizzera? La tensione è tra inclusione economica e condizionalità sociale e giuridica. Da un lato, gli stranieri lavorano, pagano contributi e imposte, e sono integrati nel sistema economico. Dall'altro, l'accesso pieno ai diritti sociali dipende dal tipo di permesso, dalla durata del soggiorno, dalla nazionalità e dalla situazione economica. Il welfare protegge dai rischi, ma per gli stranieri questa protezione entra in tensione con la politica migratoria: chiedere aiuto può mettere a rischio il diritto di restare.

Quali sono i tre criteri che determinano i diritti sociali degli stranieri in Svizzera? I tre criteri sono: la **contribuzione** (ha lavorato e versato contributi? → AVS, AI, disoccupazione), la **residenza** (vive stabilmente in Svizzera con quale statuto? → assicurazione malattia, aiuto sociale, prestazioni cantonali), e lo **statuto**

(che tipo di permesso ha? → permesso C con ampio accesso, permesso N con diritti molto limitati, sans-papiers con diritti quasi inesistenti).

Cos'è il "problema della non-domanda" e perché è rilevante per un operatore sociale? Il problema della non-domanda descrive il fenomeno per cui molte persone straniere rinunciano a richiedere aiuto sociale — anche quando ne avrebbero diritto — perché temono conseguenze sul rinnovo del permesso di soggiorno. Gli effetti sono gravi: indebitamento, rinuncia alle cure, precarietà abitativa, peggioramento della salute. Per un operatore sociale questo crea un dilemma etico fondamentale: supportare una persona nell'esercizio di un diritto formale può mettere a rischio la sua stabilità residenziale. La domanda provocatoria del prof: se esercitare un diritto mette a rischio il soggiorno, è davvero un diritto?

Perché la LAMal è considerata un "unicum" rispetto alle altre assicurazioni sociali svizzere? La LAMal è l'unica assicurazione sociale svizzera i cui premi non sono proporzionali al reddito. Tutte le altre (AVS, AI, disoccupazione) prevedono contributi calcolati in percentuale del salario. Con la LAMal, un povero e un ricco pagano lo stesso premio. Questo la rende intrinsecamente iniqua: è un peso relativamente molto più pesante per chi ha redditi bassi. Il correttivo principale sono i sussidi IPT, ma non riescono a risolvere l'inequità strutturale del sistema.

Quali sono i quattro fattori che spiegano la crescita continua della spesa sanitaria svizzera? Il progresso tecnologico (farmaci più efficaci ma più costosi), l'invecchiamento della popolazione (più anziani = più cure = più costi), la malattia dei costi di Baumol (i servizi alla persona non si automatizzano → produttività bassa → costi strutturalmente alti) e le aspettative crescenti della popolazione (più persone cercano assistenza medica per problemi che prima venivano gestiti diversamente).

Come si manifesta la solidarietà verticale e quella orizzontale nel sistema sanitario svizzero? La solidarietà verticale si manifesta attraverso le imposte progressive: chi guadagna di più contribuisce di più al finanziamento pubblico degli ospedali e dei sussidi IPT. Chi ha un reddito imponibile sotto i 20'000 CHF non paga imposte; le aliquote aumentano progressivamente all'aumentare del reddito. La solidarietà orizzontale si manifesta nell'assicurazione

malattia (tutti pagano i premi, ma solo i malati beneficiano delle prestazioni — i sani finanziano i malati) e nell'AVS (i lavoratori attivi finanziano le pensioni degli anziani).

Collegamenti

- **Lezioni precedenti:** statuto di stagionale e storia dell'immigrazione; film *"La prodigiosa trasformazione della classe operaia in stranieri"* (Samir, 2024); lezione sul lavoro precario e sindacati (stranieri sovrarappresentati nei lavori poco pagati)
- **Prossima settimana:** seminario su immigrazione e coesione sociale; lezione sull'assistenza sociale (aiuto sociale)
- **Anno prossimo:** corso sulle migrazioni (politiche migratorie in dettaglio); asilo e protezione internazionale
- **Studio chiave:** Borrelli, Kurt, Achermann, Pfirter (2021) — "(Un)Conditional welfare? Tensions between welfare rights and migration control in Swiss case law"
- **Votazione del 14 giugno 2026:** iniziativa sul limite dei 10 milioni di abitanti — collegata direttamente ai temi della lezione (Überfremdung, sostenibilità welfare, immigrazione e coesione sociale)